

20 - 01- Maladie Inflammatoire du Pelvis (MIP) - Pr. Asmouki

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule « Maladies inflammatoires du pelvis ». Alors, l'objectif de ce cours, tout d'abord diagnostiquer une infection génitale de la femme, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi de la patiente. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous allons adopter le plan suivant, on va commencer par des généralités pour parler de l'intérêt de cette question, on va parler des circonstances des survenus des maladies inflammatoires du pelvis, des principaux germes responsables, on va voir comment faire le diagnostic clinique, quel est l'apport de la paraclinique, on va parler de certains diagnostics différentiels, des formes cliniques, des complications et on va terminer avec le traitement et la surveillance. Alors, comme généralité, par définition, la maladie inflammatoire du pelvis se définit par l'infection des trompes et des organes de la reproduction dans la cavité pelvienne.

Ce terme, « pelvic inflammatory disease » ou bien « maladie inflammatoire du pelvis », c'est un terme qu'on a pris des anglophones, en général, c'est l'équivalent des alpingites chez les francophones. Alors, cette pathologie infectieuse de la femme, surtout jeune, peut entraîner des conséquences très graves, notamment concernant la stérilité et également, ça peut être source de séquelles qui peuvent entraîner des grossesses extra-utérines par la suite, de la formation d'abcès pélipiens et de la persistance de douleurs pélipiennes chez les femmes. Donc, c'est une situation qui est très fréquente, qui est très grave, qui atteint essentiellement les femmes jeunes qui ont des désirs de grossesse et ce désir de grossesse peut être compromis si jamais elles font cette maladie inflammatoire du pelvis.

Ça engendre un coût élevé pour la société, vu la fréquence et l'importance des moyens mis pour le traitement. Alors, concernant les circonstances décévenues de cette maladie inflammatoire du pelvis, il y a essentiellement deux grandes situations. D'abord, les infections génitales, notamment les MST, par le gonocoque et le clamidié, c'est de loin la situation la plus fréquente qui entraîne des maladies inflammatoires du pelvis.

La deuxième situation, ce sont les gestes endo-utérins ou les manœuvres endo-utérins. Alors, ces manœuvres endo-utérins, si jamais on ne respecte pas les contre-indications, c'est-à-dire l'infection génitale basse, on peut ensemencher le haut appareil génital par des germes qui peuvent être présents au niveau du bas appareil génital. Alors, parmi ces manœuvres endo-utérins, on va parler de l'hystérosalpingographie, qui est l'opacification de l'utérus et des trompes par voie basse.

L'hystéroscopie, qui est également un geste endo-utérin. L'éclutage dans le cadre des fausses couches. Également, les interruptions volontaires de process, si jamais on ne respecte pas les contre-indications, c'est-à-dire l'infection génitale, il va falloir traiter avant de le faire.

Bien sûr, dans le cadre de l'obstétrique, tout ce qui est délibérance artificielle et visio-utérine, si jamais il y a un contexte infectieux, ça peut ensemencher l'appareil génital. L'autre situation, qui

est également le stérilisé des dispositifs intra-utérins, dont la principale contre-indication, bien sûr, c'est la présence d'une infection génitale basse, qu'il va falloir d'abord traiter avant de l'insérer. Rarement, à part ces deux grandes situations, c'est-à-dire les infections génitales et les manœuvres endo-utérines, rarement on pourra avoir une maladie infectieuse de plus, secondaire à une infection de voisinage, comme une appendicite ou une zygomélie.

Ces situations-là peuvent propager l'infection vers l'appareil génital basse. Mais de loin, ce qu'il faut retenir, c'est que, essentiellement, les MST et, en second lieu, les gestes endo-utérins qui sont faits lorsqu'on ne respecte pas les contre-indications et lorsqu'on ne suit jamais ou n'est obligé de les faire, il va falloir les faire avec une antibioprophylaxie. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont les instruments qu'on peut utiliser dans les gestes endo-utérins.

Un stérémètre pour mesurer la hauteur de la cavité utérine. Le deuxième instrument, c'est une curette pour faire des curettages. Ça, c'est une curette qui mousse.

Le troisième instrument, c'est une curette qui est tranchante, qui est pénétrée. Et ce sont des instruments qu'on introduit à travers le col pour entrer à l'intérieur de la cavité utérine, qui peuvent être responsables de l'infection, des maladies inflammatoires du pelvis. Là, on voit des dilateurs, ce sont ce qu'on appelle des bougies, et qui sont de différents diamètres.

Lorsque le col est fermé et qu'on veut accéder à l'intérieur de la cavité utérine, on est obligé de dilater le col pour pouvoir y insérer les instruments dont on a parlé au début. Donc, vous connaissez tous ce stérilose. C'est un dispositif intratérin, et ça pose, fait partie des gestes intratérins qui peuvent être responsables des maladies inflammatoires du pelvis.

Le dernier instrument, c'est une pince de bougie qui permet de tenir le col pour qu'on puisse soit le dilater, soit de faire des gestes intratérins. Ça, c'est, on montre juste ces instruments pour que les gens le connaissent. Alors, les principaux germes qui sont responsables de cette maladie inflammatoire du pelvis, bien sûr, les germes des MST, les mycoplasmes et le rhéoplasme, certains germes pathogènes opportunistes qui sont présents.

On n'est pas normal dans le vagin, mais qui peuvent, dans certaines situations de diminution de l'immunité, être responsables d'infections génitales hautes. Et plus rarement, les infections spécifiques comme la tuberculose et la pilaire, qui peuvent être responsables de ces plus rares situations de maladies inflammatoires du pelvis. Alors, on va parler un petit peu des germes des MST.

Le chef de file, de loin le plus fréquent, c'est le chlamydia. Le chlamydia trachomatis. Dans 60% des maladies inflammatoires du pelvis, la plupart des écrits parlent de cette fréquence qui est importante.

Alors, pour rappel, c'est une bactérie intracellulaire. Qui dit bactérie intracellulaire dit que le diagnostic, on ne va pas se contenter juste d'un prélèvement bactériologique. Il faut faire un

prélèvement bactériologique spécial pour racler la muqueuse et l'amener pour l'étude des germes intracellulaires.

Du fait, c'est connu également pour le chlamydia, il n'entraîne pas d'infections aiguës. Et souvent, l'infection passe inaperçue, dans peu de signes, malgré le fait qu'elle est très destructrice de la muqueuse. Bien sûr, sa mise en évidence est difficile.

Alors, deuxième germe, c'est un germe qui est également connu dans les infections génitales. C'est le gonocoque. C'est l'agent des infections urogénitales.

Ça part dans les infections dont la maladie inflammatoire du pelvis est moindre que celle du chlamydia. Bien sûr, la symptomatologie, au contraire du chlamydia qui donne typiquement, classiquement une maladie qui n'a pas bruit. Le gonocoque donne beaucoup de symptômes.

La symptomatologie est très bruyante, notamment le corail, la douleur. Alors, d'autres germes intracellulaires peuvent être rencontrés. Les mycoplasmes, les rhéoplasmes.

Pour les germes pathogènes opportunistes, le staphylococque, le staphylococque, le zoonotérocoque, certains anaérobies qui peuvent devenir pathogènes dans certaines situations. On en a déjà parlé dans les infections spécifiques, la tuberculose et la bilharziose qui sont devenus exceptionnels. Alors, c'est une planche, c'est une diapositive qui montre l'évolution, l'histoire de la maladie inflammatoire du pelvis.

Souvent, ça commence au niveau du bas appareil génital, par une cervicite. Cette cervicite peut monter au milieu entre les endométrites et au-delà de l'utérus. Au niveau des trompes, au niveau des vers, ça peut être responsable de certains génites, de varices, voire carrément d'abcès et bien de péritonites.

Alors là, on voit une cervicite, l'aspect du col normal, lorsqu'il est rose, il n'est pas inflammé. Lorsqu'il est clair, au moment où il est abondant, il est d'aspect clair, on peut être sûr que ce n'est pas une infection du col. Par contre, ces aspects-là sont rouges, avec des pertes grisâtres ou verdâtres, c'est typique des infections génitales.

Il faut essentiellement penser aux chlamydia et aux autres germes, notamment le gonocoque ou le trichomonas. Donc, lorsqu'on suspecte une infection, une maladie inflammatoire du pelvis, parmi les choses importantes, c'est de voir le col. Lorsque le col est sain, il faut vraiment penser à autre chose.

Par contre, lorsque le col est inflammé, c'est en faveur du diagnostic d'une maladie inflammatoire du pelvis. Alors, pour le diagnostic clinique, très important, c'est l'interrogatoire. Les facteurs de risque de faire une maladie infectieuse sont connus, sont classifiés, il faut les retenir.

C'est surtout les femmes jeunes, surtout un profil de femmes qui ont des partenaires multiples. Lorsque les femmes font des rapports sexuels non protégés, sans préservatif, c'est une notion de

rapports sexuels non protégés qui précède une symptomatologie évocatrice d'une maladie inflammatoire du pelvis, doit nous aider à penser à ce diagnostic. Bien sûr, les femmes, beaucoup de femmes qui font des récurrences de MST, la présence d'anticorps de MST ou de Selpet doit faire également penser à ce diagnostic-là.

On demande également ce qu'il y a des signes fonctionnels chez le partenaire. Si jamais le partenaire est également sous traitement, ou bien qu'il souffre de signes et symptômes, ou même d'urétrite, il faut également penser à ce diagnostic-là. Situation qui est flagrante, lorsque, après un geste ondulatoire, la femme présente une symptomatologie, on doit penser à ce diagnostic en premier lieu.

Alors, ce qui concerne le terrain, ce sont les facteurs de risque de la maladie inflammatoire du pelvis, le jeûnage, les rapports sexuels non protégés, les partenaires multiples, les antécédents d'un MST ou Selpet, la présence d'urétrite chez le partenaire ou du signe fonctionnel, et bien sûr, l'existence d'un geste ondulatoire. Pour la symptomatologie, elle est très variable, elle est très variable. Néanmoins, il faut retenir la triade douleur pelvienne, fièvre, localisée, pathologique.

Alors, ces douleurs pelviennes sont récentes, elles peuvent être bilatérales au début ou devenir bilatérales. Parfois, elles sont très intenses. Parfois, elles ne sont pas intenses.

Elles peuvent éradiquer vers les organes de voisinage. Alors, la fièvre n'est pas toujours présente. Parfois, elle peut être élevée.

Parfois, elle peut s'accompagner de frissons. Et le plus souvent, ça contraste avec un état général qui est bien conservé. L'absence de fièvre ne doit pas éliminer le diagnostic.

Elle peut être présente dans 60-70% des cas, mais 25% des patients peuvent ne pas présenter de fièvre. Donc, l'absence de fièvre ne doit pas écarter le diagnostic. Lorsque la femme rapporte des localisations abondantes, anormales, c'est-à-dire jaunâtres, parfois purulentes, ça doit être en faveur du diagnostic.

Il y a certains points dont on va prendre un diagnostic, dont les formes cliniques qui peuvent s'accompagner d'un petit saignement, de l'étroragie avec les localisations. Également, du fait qu'il y a le chlamydia, on peut avoir des signes urinaires relatifs de prolapse, de brûlure médicamenteuse. On peut avoir également des signes d'irritation péritoniale.

Les organes du pelvis sont en contact intime avec le pecton qui peuvent diffuser l'infection. Ces signes d'irritation péritoniale sont connus comme des nausées, des ballonnements abdominaux, une constipation. Toujours, toujours, devant une douleur péripéenne chez une femme jeune, ne jamais oublier de demander la date des dernières règles.

Une douleur péripéenne, toujours, on va parler des causes différentielles. Ça peut orienter vers l'infection, mais ce qu'on craint également, c'est une éventuelle grossesse extra-utérine. Donc, si

jamais il y a un retard de règle, c'est un diagnostic qu'il va falloir retenir.

Alors, ceci concernant les signes fonctionnels, concernant l'examen clinique, notamment l'examen gynécologique. Il faut faire un examen gynécologique soigneux, voir les bubs et le vagin. On peut avoir une inflammation du vaginale, une inflammation du mya, le létéral, ou bien des glandes vulvaires, les glandes de Sken ou de Bartolomé, qui doivent nous attirer l'attention vers l'infection génitale basse.

On va voir l'écoulement, si il est abondant, voir son caractère, le purulent, sa couleur, le fait que ce soit teinté de son, ce qui est possible également. Alors, c'est l'ocoréla, il faut toujours essayer de confirmer qu'il s'agit d'une infection, bien sûr. Donc, il faut faire un prélèvement et envoyer au laboratoire pour études bactériologiques.

Ce prélèvement doit se réaliser après la pose d'un spéculum, soit au niveau du cul ou au niveau de l'endocole. Alors, parmi les symptômes que l'on peut trouver également à l'examen gynécologique, l'aspect de la glaire. Une glaire qui claire avec un col qui est d'aspect normal, rose, doit éloigner le diagnostic.

Par contre, une glaire qui est louche ou bien purulente, ou bien un col qui est inflammé comme on a vu dans les images tout à l'heure, ça doit aider, ça doit renforcer la suspicion de cette maladie inflammatoire du pélvis. Alors, le toucher vaginal, lorsqu'il y a une infection génitale, une maladie inflammatoire du pélvis, c'est un toucher qui est très douloureux. La présence d'une douleur vive au moment du toucher vaginal, surtout au niveau du cul ou du sac vaginolatéraux, et qui sont exacerbées par la mobilisation au moment de la palpation de l'hypogastre, de l'utérus.

Ceci doit également faire penser, suspecter une maladie inflammatoire du pélvis. Bien sûr, la grossesse extérieure n'est pas également donnée, même type de douleur, ce qui fait qu'on doit demander à l'ADN un règle, ou un moindre doute, demander un test de grossesse. Parfois, le toucher vaginal peut déjà palper et sentir un empatement douloureux au niveau du cul ou du sac vaginolatéraux, qui doit faire penser à un abcès au niveau de cette région-là.

La palpation abdominale est toujours démise et peut trouver une sensibilité au niveau de l'hypogastre, de la partie inférieure de l'abdomen, une douleur spontanée ou provoquée, parfois carrément une défense. Ce qui doit la différencier de la péritonite, c'est l'absence de contracture. Si jamais il y a une contracture, c'est un stade qui est plus avancé, il faut plutôt penser à une péritonite et voir qui est sur l'origine.

Sans oublier que l'infection d'hydrobase, s'il est maltraité, s'il est oublié, quoi que ce soit, ça peut donner une péritonite à point de départ gynécologique. Alors, ceci concernant l'examen clinique. Alors, l'examen paraclinique, on doit essayer de trouver les stigmates de l'infection, l'hyperloquiciteuse, l'élévation de l'AVS, l'élévation de la CRP.

Ne pas hésiter à faire des prélèvements bactériologiques répétés. Bien sûr, lorsqu'il y a un

contexte d'infusion de BGI, de grossesse, ne pas hésiter à demander l'hépat-CG. S'il y a des signes urinaires, il faut demander systématiquement le CBU.

Les sérologies doivent être également demandées, les sérologies chlamydiennes, microplasmies, sachant que le chlamydia, c'est un genre qui retrouve difficilement la bactériologie, parfois la sérologie clinique. Sérologie de la syphilis, TPH, AVDL, sérologie de l'HIV, sérologie de l'hépatite. Bien sûr, toujours, lorsqu'on suspecte une maladie inflammatoire du pelvis, une infection génitale, chez la femme, ne pas hésiter à demander un bilan d'infection chez le partenaire d'infection génitale.

Bien sûr, la place de l'échographie, dans les formes de début, va être normale. Par contre, dans les formes plus avancées, on va la faire essentiellement pour rechercher la présence d'un éventuel abcès pelvien. L'abcès pelvien, si on peut traiter la maladie inflammatoire du pelvis au début par des antibiotiques, l'abcès pelvien, souvent, il nécessite une évacuation chirurgicale.

Souvent, il est réalisé par la coloscopie. Alors, une question que je pose souvent au cours de l'examen, est-ce que la coloscopie est obligatoire pour le diagnostic? Elle n'est pas obligatoire pour le diagnostic. Elle est essentiellement indiquée lorsque c'est une femme jeune, qu'il y a un désir de grossesse, une indigeste.

C'est là où on veut faire le bilan des ovaires, des trompes, des ovaires, du doublet. Est-ce qu'il y a des sévéroses? Pour faire le diagnostic, pourquoi traiter? Ou bien lorsque les éléments qu'on a, il nous reste un doute diagnostic. Donc la coloscopie n'est pas systématique, il faut la réaliser seulement lorsqu'il y a un doute diagnostic ou bien lorsque la femme est très jeune, qu'il y a un désir de grossesse et qu'on veut faire le diagnostic et voir le bilan des ovaires, c'est-à-dire le pronostic.

Et bien sûr, la coloscopie, lorsqu'il y a des abcès, on peut les aspirer, on peut les faire un lavage, participe également au traitement. En ceci, concernant l'appareil clinique, un chapitre du diagnostic différentiel, il est très important devant cette maladie inflammatoire du pelvis. Bien sûr, on va évoquer toutes les étiologies du pelvis péritonéale et parfois du pelvis péritonéale.

Si c'est à droite, on ne va pas, on va toujours penser aussi à l'appendicite qui est fréquente. Si c'est au milieu, c'est surtout les infections urinaires basses. L'HGU doit toujours être à l'esprit.

Donc, devant toutes les douleurs péritonéales, on va évoquer ces diagnostics-là. La torsion d'annexe également. Certaines formes de pathologies hypogastriques, gastriques, peuvent donner des douleurs péritonéales.

Les sigmoïdes diverticulaires, qui sont plutôt fréquents dans les pays occidentaux, doivent également évoquer ces douleurs. Donc, devant toute femme qui a des douleurs péritonéales, surtout aiguës, il faut rapporter tous ces diagnostics-là et de voir les éléments pour, les éléments contre, en faveur de chaque diagnostic, avant de retenir le diagnostic final. Donc, ceci concernant

les diagnostics différentiels.

Concernant les diagnostics, les formes cliniques. Alors, la forme, c'est rare de trouver la forme typique. Souvent, c'est des formes atypiques.

Il va falloir assembler beaucoup d'éléments pour ne pas connaître ce diagnostic-là. Alors, parfois, il n'y a que des douleurs phagées. Parfois, il y a des météorologies.

Les météorologies ne vont pas éliminer le diagnostic. Je vous dis que l'inflammation du col ou bien l'inflammation de la muqueuse génitale peut s'accompagner d'un petit saignement. Un saignement, il ne doit pas éliminer une infection, une maladie inflammatoire du pelvis.

Comme, bien sûr, il ne doit pas éliminer une autre cause, notamment une pathologie, une écologie. Alors, deux diagnostics qu'on trouve dans tous les bouquins qui traitent de la maladie inflammatoire du pelvis, c'est le syndrome de Fitzhugh-Curtis. C'est une péripathie typique.

Sa particularité, c'est que ça entraîne, lorsqu'on fait une stéoscopie, des adhérences accordéons qui vont depuis le pelvis jusqu'à l'hypochondre droit. Donc, l'échographie peut aider. C'est la stéoscopie qui pose le diagnostic.

Ça, c'est un diagnostic. Il ne doit pas imprimer les maladies inflammatoires du pelvis. C'est souvent dû au chlamydia.

L'autre diagnostic, c'est lorsque ça s'associe avec des arthralgies. Il faut savoir penser au syndrome de Fitzhugh-Curtis, le roi Reiter. Donc, chapitre complications, il y a les complications qui sont aiguës et les complications à moyen et à long terme.

Concernant les complications aiguës, il peut s'agir d'un tableau d'abdomen chirurgical avec syndrome d'infection sévère par pilvipéritonite. C'est la collection périllante au niveau de la partie inférieure du péritoine, de la cavité péritoine, c'est le pilvipéritoine. Comme il peut s'agir d'une infection plus localisée au niveau de la trempe, qui peut entraîner des puces atypiques, ou bien des abseils ovariens, parfois carrément des fistules vers l'appareil urinaire ou l'appareil digestif.

Ça, c'est le tableau abdominal chirurgical. Alors, dans ce tableau-là, ça doit imposer directement un traitement par voie chirurgicale, par voie sinuscopique de préférence, sinon par la parotomie. Une situation particulière, c'est la présence d'un abseil au niveau du cul-sac de Douglas.

On sait que le cul-sac de Douglas est accessible par voie basse, par le spéculant. Dans ce cas-là, on pourra essayer d'évacuer cet abseil de Douglas par une incision du cul-sac vaginal postérieure, ce qu'on appelle une colpotomie postérieure, pour éviter un geste, une laparotomie ou une celloscopie. Donc, ça permet d'évacuer le pus, de faire le diagnostic et de traiter.

Donc, dans cette image-là, on voit un utérus, un pilvis qui est très inflammé, un utérus inflammé. Et surtout, ce qui est boudiné ici, c'est une trempe. C'est un piosalpinx.

Et avec ces images-là, typiques du piosalpinx, donc c'est une trompe qui obtient sa partie intestale, qui est remplie de pus. Et ça donne des symptômes très importants. Souvent, on s'énoscope plus quand on voit cet aspect-là.

Il faut faire une incision, aspirer le pus, envoyer un appât, faire un lavage abondant et un drainage. Bien sûr, en plus des antibiotiques. Alors, concernant les complications à moyen et à long terme, ce sont les plus fréquents qui peuvent être responsables d'inflammations résiduelles avec des adhérences.

Alors, ces adhérences-là peuvent être responsables de lésotubères, de l'amyose tubère, d'un phimosis tubère qui est une sténose de la trompe, une sténose incomplète de la trompe qui donne ce qu'on appelle un phimosis. Cette sténose peut être complète et peut entraîner un utérus alpinx. La différence entre l'utérus alpinx et le pus alpinx.

Le pus alpinx, comme son nom l'indique, c'est du pus. L'utérus alpinx, c'est une infection qui est ancienne, qui est plus ou moins guérie, mais que la trompe n'a pas reprise sa forme mobile, souple, initiale et obstruée. Il contient un liquide.

Et souvent, lorsqu'on fait un bilan de stérilité, qu'on demande soit une comparative, soit une stérilisation anglophone, on va trouver des images typiques d'utérus alpinx qu'il va falloir reperméabiliser. Parmi les complications également qu'on peut trouver lorsqu'il y a une inflammation du pus de vis, ça va tenter sur la fonction ovarienne et ça va tenter également sur la forme de l'ovaire. Ça peut entraîner des dystrophies cystiques ovariennes.

Alors, qui dit adhérence, qui dit lésions tubères, dit que le risque de grossesse extra-utérine après l'épisode de maladie inflammatoire du pus de vis, ce risque-là, il est augmenté. Bien sûr, en plus, ces adhérences-là, tout ça, c'est dû aux adhérences. Ça peut entraîner des algées pilvèles chroniques, très gênantes pour la femme, parfois handicapantes.

Ces algées pilvèles peuvent être également sous forme de dysparomie profonde, c'est-à-dire de l'eau au moment des rapports sexuels. Ce sont des complications qui sont décrites dans les complications chroniques à long terme de ces maladies inflammatoires du pus de vis. Ce qui guette également ces femmes-là, c'est un terrain, on l'indique dans le terrain, l'antécédent d'infection chimitale.

C'est des femmes qui peuvent récidiver de ces infections-là et que cette infection-là peut parfois devenir chronique. Alors, cette image-là montre une femme qui a dépassé la phase ignite de la maladie inflammatoire du pus de vis, mais qui a gardé des séquelles. Vous voyez ce trompe-là qui est fermé, c'est un hydrosalpinx.

Ce n'est pas rouge, ce n'est pas inflammé. L'épisode inflammatoire est passé. Mais c'est compliqué par des adhérences qui ont obstrué finalement ce trompe-là.

C'est des femmes qui se présentent pour stérilité parce que l'espérmatosomie ne peut plus passer au niveau du tiers externe de la trempe pour faire la fréquentation. Et donc, c'est un problème qui cause des stérilités et qu'il va falloir opérer pour biolysier cette trempe-là pour espérer avoir des grossesses. Alors, le traitement, vu que c'est une situation qui est très grave, qui peut se compliquer avec beaucoup de complications, il est obligatoire, il est en urgence.

Et vu la diversité des gens qui sont responsables, il va falloir donner une biantibiothérapie au minimum qui est synergique et avec une diffusion intrasimilaire vu la possibilité du chlamydia ou du germe intrasimilaire. Alors, au début, toujours, cette antibiotérapie doit être administrée par voie intraveineuse. Bien sûr, dès que le prélèvement est terminé, le prélèvement ne doit pas retarder le début des antibiotiques.

Et bien sûr, cette antibiotérapie pourra par la suite être adaptée en fonction des résultats de l'antibiogramme. Cette antibiotérapie devra être prolongée au moins 48 heures après la pyrexie et puis relayée par un traitement par voie intraveineuse. Alors, il y a trois possibilités.

Soit qu'on donne le moxiline avec un acide clavamique avec des cyclines, soit en cas d'allergie, au lieu d'une bétalactamine, on donne des fluoroquinolones, l'oflocète ou le pefloxacin. Soit on donne cette association-là, un moxiline, un acide clavamique avec un aminosine et un anti-anaérobies, c'est-à-dire le metronidazole. Donc, la troisième option est essentiellement privilégiée lorsqu'on suspecte un geste endométrien.

Les gestes endométrins, c'est eux qui sont responsables de ces bactéries opportunistes ou des anaérobies. Donc, cette association-là serait plus lorsqu'il s'agit d'un geste endométrin, alors que les deux premières situations, elles seront en cas d'allergie, bien la première situation lorsque c'est secondaire à une MST. Alors, s'il s'agit, lorsqu'on récupère l'antibiogramme, s'il s'agit d'un chlamydia, on maintient l'amoxiciline, l'acide clavamique pendant 15 jours et les cyclines doivent être presque au minimum 3 semaines jusqu'à 6 semaines.

Lorsque le prélèvement ne rapporte que le gonocoque, le traitement, il est beaucoup plus facile. C'est de l'amoxiciline, 3 grammes par jour pendant 15 jours. Il y a une autre option, c'est la recycline, 2 grammes par jour pendant 15 jours.

Bien sûr, s'il s'agit d'un contexte anaérobie, lorsqu'il s'agit d'une anaérobie, on doit absolument maintenir le nitrofurantoin pendant 2 jours. Alors, concernant les mesures associées à l'antibiothérapie et à l'hospitalisation, si jamais c'est dû à un dispositif intra-utérin, il faut faire la sonablation et l'envoyer à la bactériologie pour nous aider à diagnostiquer de quel type de germes. Le repos est toujours bénéfique pour accélérer la guérison et diminuer les séquelles.

On pourra céder, parce que la douleur est très importante, tant algique, tant spasmodique ou de glace sur le ventre. Souvent, on a l'habitude de périscliser une contraception orale pour éviter le risque d'abcès ovarien et surtout pour éviter les dystrophies de l'ovaire qui sont dues à une

inflammation de voisinage. Alors, concernant la surveillance, elle est essentiellement clinique, alors qui se base sur la température.

Si jamais la femme a été efficace auparavant et la présence de l'opioïdine. En général, lorsque le traitement est correct, les douleurs doivent disparaître en 2-3 jours, de même que la déformation thermique. S'il n'y a pas de disparition de douleur, s'il n'y a pas de disparition de la fièvre, il faut penser à l'éventualité d'un abcès et demander une imagerie, notamment une échographie.

Si jamais c'est un abcès, il faut être plus agressif, notamment il faut faire un drainage chirurgical, soit par stéréoscopie, soit par orthopédie. Alors, la surveillance paraclinique et surtout la minération en formation de l'ABS-CRP qui doit être renouvelée deux fois par semaine jusqu'à la disparition de l'hyperleucocytose et la normalisation de l'ABS et de la CRP. Un contrôle bactériologique à la fin du traitement, après 15 jours.

Lorsqu'il s'agit d'autres gères, on vient après 3 semaines de surveillance chirurgicale clinique. Et les surveillances sont notables pour être sûr qu'on a éradiqué l'infection. Alors, en conclusion, les formes typiques sont rares.

Ce sont surtout les formes subiguës qui sont fréquentes. Ça, il faut le refayer. Les deux principales idéologies, ce sont les infections génitales.

De loin, suivi par les gestes endolytérantes dont on a parlé tout à l'heure. Le chlamydia trachomatis, c'est le principal germe. Dans ce plus déjà 100% des cas.

Le diagnostic de certitude, c'est-à-dire qui permet de prélever le germe au niveau du site de l'infection, c'est la sélescopie. Sauf qu'il n'est pas systématique. Il est réservé lorsqu'il y a un but diagnostique.

Surtout chez la femme jeune qui a un désir de grossesse. Mais c'est parce que ça permet et le diagnostic et le diagnostic et le traitement. Le traitement antibiotique doit en moins, doit comporter une association d'au moins deux antibiotiques synergiques.

Les complications principales qui sont fréquentes, ce sont les séquelles tubaires. Bien sûr, on n'a pas parlé de la prévention. La prévention de ces maladies inflammatoires.

Passe par la prévention des MST. Bien sûr, les préservatifs et les rapports protégés. Bien sûr, lorsqu'on fait un geste androïdaire, il faut respecter les contre-indications d'amnioinfection.

Il faut la traiter avant de le faire. Bien sûr, un traitement précoce des infections basses. Et je vous remercie.